

16장. 비뇨기계의 병증 및 질환

제 2절 부종

1) 분류

1. 양수와 음수의 구분

변증	증상	치법	치방
陽水 양수 (풍수, 습수, 습열)	발열, 구갈, 심번 소변단적, 대변비결 맥침삭	소풍해표 선폐리수	월비탕 소청룡탕 오령산 습 육일산 팔정산 사령오피산
陰水 음수 (비허, 폐허, 신허)	편신부종 身無熱象, 불번갈 대변당사, 소변 少하며 黃赤하지 않음 腹脹氣短 맥침지	온보비신	실비산 금궤신기환 삼령백출산

2. 원인별 분류

변증	증상	치법	치방
1) 風水腫	두면부 부종 腰部 이상의 부종 손으로 누르면 들어감 오한, 발열 해수기급	소풍발한	월비가출탕
2) 濕水腫	腰部 이하의 부종 남아의 음낭 모두 부음 腹滿 소변 短少, 黃赤	리수삼습	침향호박환 보중치습탕 실비산 가감위령탕
3) 風濕腫	전신의 부종	상하를 나누고 외산내리	삼습탕 복령도수탕 (輕) 소착음자 (重)
4) 脾虛水腫	身倦 소기나연 腰 이하의 부종이 심함 腹脹 식욕부진 대변 溏薄 소변 短少	건비익기 행수소중	실비음 삼령백출산
5) 肺虛水腫	면색 晄白 족배부 부종이 심함 호흡기축하며 움직이면 심해짐 聲低 畏冷 심계 설담태백	건폐익기 소중	보폐탕
6) 腎虛水腫	寒狀이 나타남 음낭종대 면색 晄白 喘咳 불능평와 설담반유치흔, 맥침세	온신부양 화기행수	진무탕

제 3 절 임 증 - 요로 질환

1. 개요

임증 : 尿道澀痛 欲解難出 閉塞不通 小腹急痛引臍 하는 증상 소변을 볼 때 아프고, 시원하게 나오

지 않거나 아예 나오지 않는 증상들

《동의보감》八淋으로 분류 = 五淋(노림, 혈림, 열림, 기림 석림) + 고림, 사림, 냉림

3. 변증시치

- 요로감염의 특징 : 혈액검사 상 WBC 수가 5 이상이며 현미경 상 RBC가 보인다.

변증	증상	치법	치방
1) 寒淋(冷淋)	소변폐색, 소변 淋瀝不暢 복통난인, 견인소복작통 遇寒痛劇, 得熱痛減(추위를 앉았으니 열로 통증을 줄여줘야 한다) 사지청냉 先戰戰 然後尿 曰 : 한림의 감별법 한에 의해 나타났으므로, 몸에 차서 통증이 나타난다는 표현이 있다.	온양산한 지통리수	오령산 가미
2) 熱淋 다빈도★ (요로 감염)	- 배뇨시 급박하고 동통하다 - 소변색이 황적색이고 혼탁하다 - 소복창통하다 曰 : 열림의 감별법 열에 의해 나타났으므로, 1. 배뇨가 잘 안나와서 배뇨 시 급박하고 통증 이 나타나며, 2. 소변이 황적색이다.	청열리수통림 청리방광습열	십미도적산 팔정산 (實, 急)
3) 石淋 (요로 결석)	소변자통곤란 요로 막힐 때 有 砂石 같이 나옴 요통복 통 曰 : 석림의 감별법 돌이 있으므로, <u>오줌에 돌이 같이 나온다.</u>	청열화습 통립배석	규자산 팔정산 익원산 반총산
4) 血淋 다빈도★ (요로 감염)	-소변을 볼 때 자통과 열감이 있어, 소변이 잘 나가지 않는다 -소변색이 자홍색이고 심변이 있다. 曰 : 혈림의 감별법 혈 관련이므로, 1. 자통이 있다 2. 소변색이 자홍색이고 심변이 있다	량혈지혈 청열화습통림	소계음자

출혈성 방광염)	實	맥삭유력, 설태황 허실을 나누지 않아도 되나, 다문제에 실로 나왔다..		
	虛	허삭 통증이 악함 소변 담홍색 맥세삭		
5) 膏淋 (단백뇨)	實	소변 혼탁 (如 미감수) 오줌 속 滑膩之物 요도 열삽 동통 설질홍, 태니, 맥삭 曰 : 고림(실)의 감별법 1. 오줌속에 기름지다는 표현이 있다 2. 실증이므로 통증이 나타난다	청리습열 분청필탁	비해분청음
	虛	반복적으로 나타남 형체가 마르고 피곤함 頭昏 기름처럼 나옴(淋出如脂) 澀痛雖見減輕 설담, 태니, 맥세약무력 曰 : 고림(허)의 감별법 1. 오줌속에 기름지다는 표현이 있다 2. 허증이므로 몸이 마르다	보신고삽	가미육미지 황환
6) 勞淋		소변불심적삽 淋瀝不宣 時作時止 遇勞則發 曰 : 노림의 감별법 1.일하면 나타난다	보중익기 건비익신	보중익기탕 무비산약환

제 4절 - 산증 (음낭수종, 탈장)

1. 개요

- 산증이란 : 腹中에 作痛, 상하로 牽引, 辜丸腫痛, 少腹을 牽引하는 것
- 소아에게 가장 많이 나타나는 건 음증(수산) & 기산(탈장)

■ 음낭수종(수산)과 탈장(기산)의 감별

	음낭 수종	탈장
한방명	陰腫(水腫, 水疝)	氣疝
음낭 아래서 불빛을 비추었을 때	투명 (빛 투과)	불투명 (투과X, 장 관찰)
음낭 크기 변화	변화 X → 계속 음낭이 커져 있음 (아침/저녁에 따른 크기변화X)	변화 O → 쉬면 들어감 (아침엔 크기가 작고, 저녁엔 커짐)
		복압 증가 시 한쪽 음낭이 커짐 (많이 돌아다니거나, 배변 시 힘 줄 때)

2. 변증시지

음낭종대로 인해 내원했다고 나옵니다!

변증	증상	치법 · 처방	
1) 寒疝 (痛疝)	차가우면 통증 발병 시 음낭 청랭 結硬如石 고환이 땅기며 동통 심하면 少腹牽引 사지청랭 曰 : 한산의 감별법 1.몸이 찬 증상	解表溫中 (초기)	오두계지탕
		溫中散寒 (통증 極)	금수환
		-	반총산 오적산 당귀사역탕
2) 濕熱感寒疝	음낭이 鬆弛紅腫하고 간혹 자통 曰 : 습열감한산 감별법 1.음낭이 느슨해진단다	-	오두치자탕
3) 胎疝	출생 후 소복 하부에 결경동통 有 曰 : 태산 감별법 1.출생 후에 ~라는 표현이 나타난다	-	십미창백산 금령산 천련환
4) 陰腫 (水疝) (음낭수종) 다빈도★	-얼굴이 누렇다 -식욕이 부족하여 식사량은 작은 편이다 -늘 피곤하여 기력이 저하된다 -무른 변을 본다 (위에 증상 모두 기허증) -음낭수종의 특징 : 1. 펜라이트로 음낭을 비추면 투과하여 투명하다 2. 복압에 따른 크기 변화 X 3. 아침 저녁에 따른 크기 변화가 없다 X 曰 : 수산(음종) 감별법 (기허증상이 기산처럼 있습니다) 1.음낭수종의 특징	소적리습	① 風濕 : 소풍오령산 ② 心火 : 가미오령산 도적산 ③ 食積下消 : 가미수효환
5) 氣疝 (탈장) 다빈도★	① 기허하함 -신체가 허약하여 얼굴이 누렇다 - 늘 피곤하여 기력이 저하된다 (위에 증상 모두 기허증) -탈장의 특징 1. 펜라이트로 음낭을 비추면 빛을 투과하지 않는다 2. 배변 시 힘주면 크기 변화 O	익기승함	보중익기탕 (加 곽핵, 여지핵)

		3.자고 일어남에 따라 크기 변화 O 日 : 기산 - 기허하함 감별법 (기허증상이 수산처럼 있습니다) 1.탈장의 특징		
	㉔ 한응기체	산기 발작 후 疝 내용물 환납할 수 없음 음낭 腫硬 墮脹不舒 痛 連少腹 등 日 : 기산 - 한응기체 감별법 1.탈장의 특징 2.기허 증상 X	소간이기 온통산결	도기탕 (輕) 천태오약산 (重)
6) 少腹氣	소복이 발창동통하는 것이 고환까지 달하며 위로는 요척부를 견인하여 작통하며 증상이 극렬하여 심홍 부까지 상충한다 日 : 소복기 감별법 1.소복~심홍부까지 통증이 나타남		-	① 小腹脹痛 : 가미향소산 ② 심홍부 통증 : 가미실소산 ③ 통증 상하로 이동 : 호로파환

수업 X

소변빈삭이란? 배뇨 횟수 증가 · 통증X

2. 변증시치 – 기출 X

변증	증상	치법	치방
1) 습열하주	小便頻數短赤, 尿道灼熱疼痛, 尿液混濁, 尿頻, 尿急通 혹 發熱 煩渴	청열리습 통리방광	팔정산
2) 기허증	小便頻數 或 滴瀝不振, 納呆, 少氣懶言 脈細弱, 舌質 淡, 苔薄白	온신장양 고섭소변	가구자환 상표초산
3) 음허증	小便頻數不能自禁, 夜熱口乾 脈細數, 舌質紅, 苔薄黃	자음청열익 신	지백지황탕 증음이로탕
4) 심신불교	심리적 긴장이 원인	-	귀비탕 교감단

소변 빈삭 관련 질환

1. 과민방광

급박뇨의 증상, 5세 이상 8회/이상 배뇨, 야간뇨 · 유뇨증 동반➔ 특징적인 배뇨지연행위가 나타

남- 여아 : 서양식 인사하기, 쪼그리기- 남아 : 바지춤 잡기

2. 주간 빈뇨 증후군

10~20분 간격의 심한 빈뇨 증상, 야간뇨·유뇨증 동반 X(스트레스가 원인)

제 7절 - 유뇨증

1. 개요

- 소아기의 흔한 증상 | 5세 남아의 약 5%, 여아의 약 3%
- 진단기준 : 최소 만 5세 | 1주일에 최소 2회 이상 | 최소 3개월 이상 지속 시
- 종류
 - ① 야간 유뇨증 : 밤에 자다가 오줌을 싸는 경우 (전체의 약 80%)
 - ② 주간 유뇨증 : 낮에 오줌을 싸는 경우 (전체의 약 15%)
 - ③ 두 유뇨증이 동시에 나타나는 경우 (약 5%)
- 야뇨증 : 남아 | 첫 번째 아이 | 낮은 사회·경제적 계층 | 심한 스트레스를 경험 → 빈번하게 나타남

야간 유뇨증 (야뇨증)	▪ 가장 큰 특징 : 깊은 숙면 (깊은 잠으로 잠을 깨지 못한 상태로 소변 소변을 본 것 인식하지 못하기도 함 낮잠을 자는 사이에도 소변) ▪ 이유 : 방광에 소변이 차면 압력에 의해 뇨의가 뇌로 전달되어 뇌가 반응하고 방광을 비우도록 해야 하는데, 뇌신경 발달의 미숙으로 인해 야뇨를 일으킴	
	1차성 야뇨증	2차성 야뇨증

	▪ 처음부터 배뇨 조절을 하지 못하는 경우 ▪ 전체 유뇨증 어린이의 75% ▪ 대부분이 1차성 ▪ 유전적 소인 有 (부모의 야뇨증 과거력)	▪ 최소한 6개월 이상의 기간 동안 배뇨 조절을 하다가 야뇨증으로 나타나는 경우 ▪ 학령기 후기에 생기는 유뇨증의 50% ▪ 심리적 요인 (부모로부터의 격리, 부모의 사망, 동생의 출생, 입원 등에 의한 환경변화)
--	--	---

2. 원인

- ① 기질적 원인 :
요로감염, 오랑증가(당뇨병, 요붕증, 이뇨제), 폐쇄성 요로질환, 만성 신부전, 신경장애 등
- ② 기능적 원인 (多):
잘못된 배뇨훈련, 수면 중 각성 곤란, 정신·심리적 요인, 자율신경이상, 알레르기성, 신경학적 요인 등

★ 알레르기성 야뇨의 진단 기준

- 기질적 질환이 없음 (특히 비뇨기 질환)
- 배뇨훈련, 신경학적 문제 X
- 알레르기성 질환(기관지천식, 알레르기성 비염, 아토피성 피부염, 두드러기 등)의 과거력 및 가족력
- 소변검사 상 호산구 검출 시 진단 가능

③ 유전적 원인, 가족력

2. 변증시치

유뇨 or 야뇨증으로 내원했다고 합니다!

변증	증상	치법	치방
1) 하원허한 방광불약 기출 ★	-소변 양이 많고, 횡수가 많다 -하룻밤에 1~3회 소변을 본다 -손발이 차고 추위를 잘탄다 -피곤해하고 힘이 없다 -얼굴이 창백하다 曰 : 하원허한, 방광불약 감별점 1.소변의 양과 횡수가 많다 2.한증이 있다.	온보신양 고삽소변	상표초산 토사자한
2) 脾肺氣虛 기출 ★	- 소변량은 적으나 횡수가 많다 - 얼굴이 누렇고 말하기를 싫어한다 - 식욕부진, 자한, 대변당희 曰 : 비폐기허 감별점 1.소변량이 적으나 횡수가 많다 2. 기허증이 있다.	보익비폐 익기승양 고삽소변	보중익기탕 촉천환
3) 肝經鬱熱 (2차성 야뇨 증) 기출 ★	-소변량이 적고, 횡수도 적다 -소변이 노랑고, 냄새가 심한편이다 -성격이 급해 화가 잘내고 밤에는 잠을 잘 자지 못한다 -2차성 야뇨증의 증상 1. 심리적 요인으로 밤에 오줌을 싸게 됨 曰 : 간경울열의 감별점 1.소변량이 적고, 횡수도 적다 2.스트레스를 받고, 화를 잘 내는 등 심리적 상황이 나타난다	청사간열 좌이소리	용담사간탕
4) 心腎不交 (2차성 야뇨 증) 기출 ★	-수면 상태가 매우 불안정하다 (다동) -오심변열, 변조가 있다 -2차성 야뇨증의 증상 1. 심리적 요인으로 밤에 오줌을 싸게 됨 曰 : 심신불교의 감별점 1.오심변열, 변조가 나타난다	청심자신 안신고부	기제한

	2. 2차성 야뇨증이 나타날 수도 있다 but 간경울열처럼 심리적 상황이 뚜렷하게 나타나진 않는다(성격이 급하다, 화를 낸다)		
--	--	--	--

제 8절 – 소변백탁

■ 소변백탁이란? :

소변색이 미감수(쌀뜨물)같음 | 탁하고 맑지 않음 | 소변볼 때 통증없음 → 주증상으로 하는 질환
하나의 증상 & 적체, 충적, 감증 중후 중 나타나는 질환이기도 함 → 원발 병인을 제거하는 것이 중요

1. 변증시치

변증	증상	치법	치방
1) 乳食積滯 기출 ★	- 식욕이 없고 토한다 - 잠을 잘 못잔다 - 복부가 팽만하다 - 손과 심장이 번열하다 - 대변에서 냄새난다 曰 : 유식적체의 감별점 1.먹다가 나타난 것이므로, 식욕이 없고 토하며 복부팽만하다	소식제적 통리방광	보화환 * 복령산을 겸하여 복용 (충적 : 소감이비탕, 비아환)
2) 濕熱下注 기출 ★	- 소변이 나갈 때 붉다 - 배뇨 시에 작열감과 저체감이 있다 - 입이 쓰다 曰 : 습열하주의 감별점 1.열 증상으로 배뇨 시에 작열감과 저체감이 있다	청열리습 통리방광	도적산 비해분청음
3) 脾虛氣陷	뇨백 반복 발작 혼탁 (如백장) 소복 脹墜 尿意不暢 식소변당 신권단기 면색무화 설담태백, 맥상세연	조리비위 보기승청	보중익기탕 사군자탕 오미이공산

4) 腎虛不固	尿白遷延日久 小便乳白如凝脂 정신萎靡 소수무력, 요슬산연, 두훈이명		보신고섭	육미지황탕 육미지황탕 습 토사자환
	양허	면색광백 외한지냉 설질담 맥침세를 겸		
	음허	허열 설질홍 태소 맥세삭을 겸		

제 9절 - 용폐

- 용폐란?: 소변의 양이 적음 | 방울방울 조금씩 떨어짐 | 심하면 소변이 막혀서 제대로 나오지 않음

1. 변증시치 기출 X

변증	증상	치법	치방
1) 방광습열	小便滴瀝而下, 甚則小便不通, 尿少短赤 伴有口乾口苦口粘, 渴欲飲水 或腹脹便秘 舌質紅, 苔黃膩, 脈數	청열리습 통리소변	팔정산가감
2) 담탁내폐	尿少或尿閉, 面色灰滯, 神疲納呆, 口中尿臭, 胸悶心煩, 惡心嘔吐, 甚至神志昏潰 舌質紅, 苔濁膩, 脈弦滑	청심강역 화위설탁	황련온담탕
3) 폐열기옹	小便不暢 或點滴不通, 發熱咽乾, 煩渴欲飲, 呼吸急促 或有咳嗽, 咯痰, 痰黃而點 舌紅苔薄黃, 脈數	청설폐열 선통폐기	마행감석탕 합 청폐음
4) 심경열성	小腹急迫, 小便不通, 點滴不能出, 兼見舌紅面赤 或口舌生瘡, 心煩口渴欲飲, 飲後에 더욱 급해짐, 舌尖紅赤, 苔薄黃, 脈細數	청심사화 통리소변	도적산
5) 기허수정	小腹墮脹, 時欲小便而不得出, 或量少而不爽利 兼見神疲乏力, 面色蒼白, 氣短聲微, 食慾不振 舌淡, 苔薄白, 脈沈細無力	익기승청 행기리수	춘택탕

6) 신기불충	小便不通或點滴不爽, 排出無力, 神氣怯弱, 腰膝酸軟 或耳鳴不聰, 脈沈無力		-	
	신양부족	面色晄白, 手足清冷, 外寒蜷臥, 口舌俱淡 舌苔淡白, 脈沈而遲	온보신양	제생신기환
	신음부족	見兩觀潮紅, 口乾咽燥, 手足心熱 舌紅苔少, 脈象細數	자음잠양	지백지황환
7) 어체내조	初起自覺排尿不暢, 漸致滴瀝不暢或時通時阻 或尿如淺細, 小腹胀滿, 隱隱作痛, 面色紫暗, 脈沈澁		화어산결 통리소변	왕부유행산 합 삼금탕

제 11절 - 신질환

0. 신질환 목차

① 사구체 병증	0. 급성 사구체신염 - 사슬알균 감염 후 급성 사구체 신염, 기타 감염 후 사구체신염) 1. 급속 진행성 사구체신염 2. 신증후군 - 1차성, 2차성 3. IgA 신병증 4. HS(헤노흐-쉰라인) 자반병 신염 5. 단독 단백뇨 6. 무증상 혈뇨 7. 전신 홍반 루프스 신염 8. 유전 가족성 질환 - 알포트 증후군, 양성 가족성 혈뇨, Finnish형 선천 신증후군, 상염색체 열성 스테로이드저항 신증후군 9. 용혈 요독 증후군
② 급성 신부전증	▪ 수분 · 전해질 · 대사산물 배설X → 체액의 항상성을 유지할 수 없는 급속한 신기능의 저하 상태 ▪ 주증상은 핍뇨

③ 만성 신질환	사구체 여과율의 감소 여부에 상관없이 신장의 구조적·기능적 이상으로 신장 손상이 3개월 이상 지속됨
④ 신세뇨관 산증	신세뇨관에서 중탄산 이온 재흡수와 수소 이온의 분비 장애로 인해 전신 대사산증을 보이는 질환
⑤ 신세뇨관 간질 신병증	- 급성 요산 신병증 : 고위험군(백혈병·림프종 환자)에서 핏뇨, 고칼륨혈증, 고인산혈증, 저칼슘혈증, 고뇨산혈증, 고뇨산뇨증이 있을 경우 진단 가능 - 신세뇨관 간질 신염 : 신세뇨관 간질에 염증과 손상이 있으나 사구체나 혈관 변화가 동반되지 않는 질환
⑥ 신성 고혈압	- 신실질성 고혈압 : 신 반흔 or 급만성 사구체 신염일 때 나타남 - 신혈관성 고혈압 : 소아기 고혈압의 중요한 원인, 심한 고혈압 보임

1. 사슬알균 감염 후 급성 사구체신염 ★

1) 개요

■ 급성 사구체 신염 중 가장 대표되는 것 | 소아 급성 혈뇨의 가장 흔한 원인 | 최근 발생빈도가 많이 감소됨

원인	- 신염을 일으키는 사슬알균 감염 후 발생 - 학동 전 및 초등학교 저학년 아동에서 다발 (3세 이하에서는 드물다)
증상	주요 증상 : 부종, 핏뇨, 고혈압, 육안적 혈뇨 - 잠복기 : 감염 후 1~2주 후에 사구체 신염의 증상 나타남 (피부감염 후 생기는 건 잠복기 3~6주) - 부종 : 눈 주위에 가장 현저함 복수 동반하기도 함 대개 수일간 지속 - 핏뇨 : 사구체 여과율의 감소로 인한 핏뇨 - 고혈압 : 간혹 갑작스럽고 심한 고혈압 → 뇌증 (구토, 두통, 경련 등) - 기타증상 : 육안적 혈뇨, 쇠약감, 복통, 미열, 혈량증가, 고혈압으로 인한 심부전, 폐부종
감별진단	- 혈청 C3의 감소로 임상적 진단 가능 - 반복성 혈뇨, 만성식성신염, 유전성 신염, Henoch-Schölein 자반증 신염, 전신성 홍반성 낭창, 급성 출혈성 방광염 등과 감별

치료	- 급성기엔 증세 변화 예측X & 합병증 발생 우려 때문에 반드시 입원치료 - 급성기에 한해서 수분과 염분을 제한 (신부전이 심한 경우 이외에는 단백질 제한할 필요 X) - 염분이 가미된 음식 피하기 - 두통, 구역, 경련 등 응급을 요하는 고혈압이 있는 경우 응급치료 (대다수는 일시적, 지속되면 강압제용) - 신부전, 고혈압 등에 대한 대증요법
경과 및 예후	- 급성기는 대개 1~4주 이내 95% 이상에서 완전 회복 - 혈뇨의 소실은 대체로 6개월 이내 (소수에서는 1년 이상 지속되기도 함) 혈뇨가 있지만 무증상인 경우도 있음! - 아주 드물게 급속 진행성 사구체 신염으로 진행되기도 하고, 이는 곧 급성 신부전으로 이어져 사망 가능

2) 변증시치 (임상적 접근)

* 급성 사구체신염의 치료원칙 ★

1. 급성기 : 발한, 리수소증, 청열해독 (發汗, 利水消腫, 清熱解毒)
2. 회복기 : 청열리습, 건비고신 (清熱利濕, 健脾固腎)

급성 사구체 신염은 혈뇨 or 발열을 주소로 내원했다고 합니다

① 초기, 급성기

변증	증상	치법	치방
1) 風水證 기출 ★	- 초기 오한발열 - 안검에 부종이 있다 - 해수 - 뇨가 적다 曰 : 풍수증의 감별점 - 초기 오한발열이 나타난다	소풍청열 설편리수	월비가출탕 방기황기탕
2) 風熱證 기출 ★	- 안검에 부종이 있다 - 소변의 양이 적고 붉다 - 입이 말라 물을 먹고 싶어한다 曰 : 풍열증의 감별점 - 열증(소변의 양이 적고 붉다. 구갈희음)	신량투표 청열리수	은교산

3) 風寒證 기출 ★	- 얼굴과 안검에 부종이 있다 - 소변의 양이 적다 - 두통, 전신의 골절 산통 - 해수 曰 : 풍한증의 감별점 - 한증이므로, 두통, 전신의 골절 산통이 있다	신온해표 통양리수	마황탕 습 오령산
4) 熱毒證 기출 ★	- 얼마 전에 감염병에 걸려서, 현재까지 후유증이 나타난다 - 평소에 기름지고 매운 음식을 좋아한다 曰 : 열독증의 감별점 - 감염병에 걸려 현재까지 이어지고 있다 - 평소에 기름지고 매운 음식을 좋아한다	청열해독 리습소증	오미소독음 加 백화사 설초, 노근, 옥미수, 대청엽
5) 濕熱證	발열혹불발열, 두통신증, 면목급전신부종, 권태무력, 口苦 口粘, 尿少而黃, 大便滯而 不爽 (진흙같은 대변, 시원하게 보지 못함) 태황니, 맥부삭 曰 : 습열증의 감별점 (특히 풍열증) - 열증이 있으나, 풍열증과 다르게 습이 있어 권태무력이 나타난다	청열제습 건비리수	삼인탕
6) 寒濕證	면황복창, 지체부종혹하반신중심, 권태핍력, 소변단소 설질담, 태백니, 맥상유완 曰 : 한습증의 감별점 (특히 풍한증) - 한증이 있으나, 한습증과 다르게 습이 있어 권태무력이 나타난다	삼습리수 온위소증	오령산 습 오피음

② 회복기 기출 X

변증	증상	치법	치방
1) 脾氣虛弱	신태핍력, 납소변당, 면색창황, 자한도한, 설담태박백, 맥완약	건비익기 고신보허	사군자탕 습 보종익기 탕
2) 腎陰不足	신태두훈, 요퇴산연, 수족심열, 설홍소태, 맥세삭	보익신음	육미지향환

2. 신증후군 ★

1) 개요

①심한 단백뇨, ②저알부민혈증, ③고지혈증, ④전신부종의 증상을 특징으로 하는 임상 증후군

신사구체 간벽 기능의 결함 → 사구체 투과성 증가 → 혈청 단백(ex. 알부민)이 소변으로 소실됨

∴ 저알부민혈증, 심한 단백뇨

* 신증후군의 진단기준

(1) 혈청 알부민 ≤ 2.5g/dl → 저알부민혈증

(2) 소변 단백질량 ≥ 40mg/m²/시간 (≥960mg/m²/일) → 심한 단백뇨

① 1차성 신증후군 (특발성)	▪ 소아 신증후군의 90% 남아 > 여아 (남아에서 2배 많이 발생) 2~6세에 가장 호발 ▪ 사구체 기저막의 전하 선택성 장벽 or 크기 선택성 장벽의 기능에 이상 → 단백뇨 (정확한 원인은 X) ▪ 눈 주위의 부종으로 시작해서 점차 전신적인 부종이 나타나고, 음낭 부종이 생기기도 함 ▪ 식욕부진, 복통, 설사, 거품뇨, 단백뇨 현미경적 혈뇨 동반 가능 but 고혈압은 흔하지 X 합병증(복막염) ▪ 부종이 있을 때에는 Na 섭취를 제한(부종이 아주 심하면 수분 섭취 제한) 단백질은 통상의 양 섭취
② 2차성 신증후군	▪ 소아 신증후군의 10% ▪ IgA 신병증, Henoch-Schölein 자반증 신염, Lupus 신염, B형 간염 바이러스 감염, 약물 등에 의해 발생

2) 변증시치 (임상적 접근)

신증후군은 전신부종을 주소로 하며, 소변 단백질과 혈청 알부민의 검사 결과가 같이 나타납니다!

변증	증상	치법	치방
1) 脾虛濕困 기출★	- 면색이 위황하고 힘이 없다 - 식욕부진 복통 설사 - 손발이 차다 曰 : 비허습곤증의 감별점 - 면색 위황!	익기건비 리수소증	사군자탕습오피음 황기보중탕
2) 脾腎陽虛 기출★	- 면색광백 - 팔다리가 참 - 식욕부진 복통 설사 오심구토 曰 : 비신양허증의 감별점 - 면색 광백!	온양리수	진무탕가감 실비음가감
3) 肝腎陰虛	면색조홍 두통두훈 번조불안 수족심열 요산퇴연 설질홍 苔少或剝苔 맥현세삭 曰 : 간신음허증의 감별점 - 면색 조홍!	양음자신 평간잠양	기국지황환가감 지황음자가감
4) 氣滯血瘀	면색회암 脣色紫暗 피부건고무광택 或瘀斑 설질자암 苔少 맥삽혹현 曰 : 기체혈어증의 감별점 - 면색 회암!	행기활혈거어	도홍사물탕
5) 脾腎虛衰	面色晦滯而浮腫 형체소수 흥민복창 납소 오심구토 尿 少或清長 심계기단 번조불녕 혼미 추혹 설체반질담 태 백니혹황니 맥침세 曰 : 비신허쇠증의 감별점 - 면색 암!	부정강탁	온비탕

3. IgA 신병증

1) 개요

- 현미경적 · 육안적 혈뇨가 있으면서 사구체 혈관사이세포에 IgA가 우세하게 침착된 사구체 신염
- 무증상성 현미경적 혈뇨를 보이는 사구체 신염 중 가장 흔한 원인 중 하나
- 남자에게 호발 | 후기 아동기나 성인 초기에 많이 발생
- 상기도 감염 후 2~3일 내에 육안적 혈뇨 나타남 (cf. 사슬알균 감염 후 급성 사구체신염은 잠복기 7~14일)
- 진단 특징★ :

① 간헐적 · 육안적 혈뇨 ② 백혈구 증가 X ③ 배뇨통 X ④ 상기도 감염 후 3일 이내에 육안적 혈뇨

2) 변증시치 (임상적 접근)

IgA 신병증은 육안적혈뇨로 왔지만, WBC 증가와 배뇨통이 없다고 나타납니다!

① 급성기

변증	증상	치법	치방
1) 풍열요락 기출 ★	- 며칠 전부터 발열이 나타난다 - 목 안이 아프고, 허리가 시큰거린다 - 소변이 적색이다 曰 : 풍열요락의 감별점 - 발열이 나타나며, 소변이 적색이다	소풍청열	상곡음 습 은교산가 감
2) 下焦濕熱	요산(腰痠) 혈뇨 뇨적 尿頻不爽 완민납매 태황니 맥세 삭 曰 : 하초습열 감별점 - 오줌이 잘 나오지 않는다	청열리습	소계음자가감
3) 심화항성	심번실면 혈뇨 뇨적 뇨빈 요산(腰痠)구고 舌尖紅 태박 백 맥세삭 曰 : 심화항성 감별점	청심사화	도적산가감

	- 심번하고 잠을 잘 자지 못한다		
--	--------------------	--	--

② 만성기

변증	증상	치법	치방
1) 陰虛火旺 다빈도 기출★	- 목 안이 발적되어 있고, 허리와 무릎이 시큰거린다 - 몸은 마른 편이며, 힘이 없다 日 : 음허화왕의 감별점 (특히 풍열요약) - 발열이 나타나지 않으며, 허증이므로 몸이 말랐다	자음청열	지백지황탕
2) 氣不攝血 기출★	- 얼굴에 화색이 없다 - 기력이 없으며 피로하다 日 : 기불섭혈의 감별점 - 얼굴에 화색이 없다	익기섭혈	귀비탕가감
3) 氣滯血瘀	病程日久 요부자통 面色黧黑 血尿不斷 舌邊瘀紫 맥 세삼 日 : 기체혈어의 감별점 - 자통이 느껴진다	익기활혈	도홍사물탕 보양한 오탕

제 12절 - 요로질환

1. 요로감염 (열림, 혈림)

1) 개요 ★

- 요로(요도, 방광, 요관, 신우, 신실질)에 의의있는 세균뇨가 있는 상태
- 열이 있는 모든 소아(영아)에서는 항상 요로 감염의 가능성을 생각해야 함
- 신생아기 & 영아기 : 선천성 기형이 많은 남아가 여아보다 빈도가 높음
- 영아기 이후 : 여아의 빈도가 훨씬 높음
- 신생아기는 주로 혈행성 감염 | 그 이후는 장내 세균의 상행성 감염
- E.coli가 가장 흔한 원인균 | 1차 감염의 80% 이상 차지

2) 분류 및 정의

하부요로감염	요도염	■ 요도에 국한된 감염
	방광염	■ 방광까지만 국한된 감염
상부요로감염	급성 신우신염	■ 감염이 신우 및 신실질까지 파급된 경우
	만성 신우신염	■ 임상에서 사용하는 요관 역류 신병증과 같은 의미를 갖는 경우가 많음 ■ 실질 내의 역류와 감염의 재발로 신장에 반흔을 보이는 경우
무증후성 세균뇨		■ 아무 증후 없이 소변 배양 검사에서 세균이 존재하는 상태

3) 임상 증상 ★

단백뇨, 부종은 요로감염의 증상이 아님!

침범 부위	증상 (괄호 : 빈도수 순위)	연령군
방광	핍뇨, 배뇨곤란 (2)	연장아
	야뇨증 (6)	연장아
	열 (1)	영유아
	성장 및 발육부전 (3)	영아
신장	구토 (5)	영아
	설사 (7)	영아
	요통 (8)	연장아
방광, 신장	복통 및 치골결합상 동통 (4)	연장아

4) 치료

- 증상이 있는 요로 감염에서는 항생제의 신속한 투여가 필요함
- 무증상 세균뇨는 항생제 치료 후에 오히려 재발률이 높고, 증상성 요로 감염으로 발전하는 경우가 많아 치료하지 않음

2. 요석, 고칼슘노증 (석림)

1) 개요

- 요로계에 요석이 생성되어 소변 흐름에 장애가 초래되고, 그 결과 극심한 통증이 발생하거나 요로감염, 수신증, 신부전 등이 나타나는 질환
- 발병 원인 : 수분 섭취 감소 → 요석 결정이 소변에 머무르는 시간이 길어져 요석 형성이 증가함
- 남성 > 여성 (3배 이상) | 20~40대의 젊은 연령층 多 (7% 정도가 16세 미만에서 발생)
- 햇볕에 많이 노출되면 비타민 D의 형성이 증가되어 요로결석의 위험이 증가
- 여름에 땀을 많이 흘리면서 소변이 농축되어 요로결석의 생성이 용이해짐 (∴ 온도 · 계절의 영향大)
- 동물성 단백질 섭취 증가 → 요중 칼슘, 수산, 요산의 배설이 증가 → 요로결석의 위험이 증가
- 임상 증상 : 육안적 · 현미경적 혈뇨 | 산통, 복통 등 | 배뇨통, 급박뇨, 빈뇨 등의 방광 자극 증상
- 치료 : 초기에 다량의 수분 섭취 | 식이 염분의 제한